ORIGEM DO DOCUMENTO:			
Gerência do Serviço de Urgência e Emergência – FCECON			
TÍTULO:			**Nº DOC:**
Protocolo Institucional de Manejo do Sangramento em Pacientes Oncológicos na Unidade de Pronto Socorro no Serviço de Urgência e Emergência – FCECON.			PRT.GU.001
DATA 1ª VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
05/12/2025	05/12/2025	01	05/12/2027

1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o atendimento ao paciente oncológico com suspeita ou confirmação de sangramento.
1.2. Detectar precocemente sinais de gravidade e risco iminente à vida.
1.3. Orientar condutas de estabilização, investigação e tratamento imediato.
1.4. Reduzir complicações, eventos adversos e mortalidade associada ao sangramento.
1.5. Integrar equipes multiprofissionais para garantir atendimento ágil e seguro.
1.6. Estabelecer critérios claros de internação, observação, encaminhamento para UTI ou alta.

2. ABRANGÊNCIA

- Todos os pacientes oncológicos (adultos e pediátricos) que são cadastrados na Fundação Centro de Oncologia do Estado do Amazonas;
- Pacientes em tratamento ativo (quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapias alvo);

- Pacientes em cuidados paliativos.

Locais de aplicação:

- Classificação de risco;
- Sala de emergência;
- Sala vermelha/área de reanimação;
- Enfermarias da urgência;
- Sala de observação;
- Áreas de estabilização e preparo para procedimentos.

Envolve as equipes de:

- Medicina (clínica médica, oncologia, hematologia, cirurgia, especialistas em geral);
- Enfermagem (triagem, pronto-socorro);
- Técnicos de enfermagem;
- Banco de sangue;
- Laboratório;
- Radiologia e radiologia intervencionista;
- Endoscopia;
- Farmácia clínica.

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

O manejo do sangramento em pacientes oncológicos possui especificidades decorrentes de:

- Plaquetopenia induzida por quimioterapia;
- Coagulopatias associadas a tumores, infecções ou medicamentos;
- Mucosite grave predispondo a sangramentos;

- Tumores ulcerados ou neoplasias com invasão vascular;
- Risco aumentado de hemorragias internas.

As bases técnicas incluem:

- Suporte avançado de vida;
- Protocolos internacionais de hemotransfusão;
- Diretrizes de oncologia e hematologia para manejo de plaquetopenias e coagulopatias;
- Fluxos integrados de atendimento multiprofissional.

4. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – 5 CORES (PROTOCOLO ACR)

A classificação segue diretrizes do Ministério da Saúde, adaptada para pacientes oncológicos.

4.1. Cor vermelha – emergência (prioridade zero – atendimento imediato)

Condições:

Sinais vitais alterados (PAS < 90 mmHg e/ou PAD > 60 mmHg);

- Epistaxe com PA ≥ 180/120 mmHg;
- Epistaxe intensa;
- Hematêmese;
- Hematoquezia;
- Melena;
- Hemoptise;
- Epistaxe;
- Metrorragia intensa.

Conduta imediata:

- Sala de emergência; ABCDE; exames rápidos; conduta transfusional; controle do foco; comunicação com hematologia/oncologia; possível UTI ou centro cirúrgico.

4.2. Cor laranja – muito urgente (atendimento em média 10 min)

Condições:

- Sangramento moderado com sinais iniciais de repercussão;
- Palidez, sudorese, taquicardia leve;
- Sangramento digestivo sem instabilidade;
- Sangramento ativo.

Conduta:

- Reavaliação rápida; exames laboratoriais; reposição volêmica; controle local; encaminhamento rápido.

4.3. Cor amarela – urgente (atendimento em média 60 min)

Condições:

- Sangramento leve/moderado sem sinais de choque;
- Suspeita de sangramento interno sem repercussão importante;
- Pacientes imunossuprimidos ou com comorbidades relevantes;

Conduta:

- Exames; avaliação médica detalhada; conduta transfusional conforme resultado; possível internação.

4.4. Cor verde – pouco urgente (atendimento em média 120 min)

Condições:

- Sangramentos leves com controle local;
- Sem sinais de anemia, instabilidade ou repercussão clínica;
- Necessidade de avaliação, mas sem urgência imediata.

Conduta:

- Medidas locais; exames básicos; orientação; retorno programado ou encaminhamento ambulatorial.

4.5. Cor azul – não urgente (atendimento em média 240 min)

Condições:

- Queixas sem sangramento ativo;
- Solicitações administrativas;
- Revisões pós-evento;
- Encaminhamentos.

Conduta:

- Orientações; agendamentos; cuidado ambulatorial

5. AVALIAÇÃO INCIAL – ABCDE

Realizar abordagem sistematizada:

- **A**: via aérea, considerar intubação;
- **B:** respiração e oxigênio;

- **C:** circulação, 2 acessos calibrosos;
- **D:** nível de consciência;
- **E:** exposição e busca de sangramentos ocultos.

6. EXAMES ESSENCIAIS

- Hemograma completo;
- TAP, TTPA, INR;
- Fibrinogênio;
- Função renal e hepática;
- Gasometria;
- Tipagem sanguínea e prova cruzada (dependendo da gravidade e dos exames laboratoriais);
- Ultrassom/TC conforme suspeita.

7. CONDUTAS TERAPÊUTICAS

7.1. Controle do Foco de Sangramento

- Compressão mecânica/local;
- Tópicos hemostáticos (adrenalina tópica);
- Cirurgia ou radiologia intervencionista, se indicado;
- Ácido tranexâmico IV: 10-15 mg/kg/dose (se não contraindicado);
- Suspensão de anticoagulantes/antiagregantes (avaliar risco-benefício);
- Correção de coagulopatias específicas (ex: vitamina K, fatores);
- Intervenção cirúrgica quando indicada.

7.2. Reposição volêmica e hemocomponentes

Concentrado de hemácias:

- Hb < 8 g/dL (Pacientes com sintomas);
- Sangramento ativo + repercussão clínica;
- Hemorragias agudas com perdas volêmicas superior 25 a 30 % da volemia total.

Plaquetas:

- < 10.000/mm³: transfusão profilática sem sangramento;
- < 20.000/mm³: febre, infecção na presença de fatores associados a eventos;
- < 50.000/mm³: Sangramentos ativos ou procedimentos;
- < 100.000/mm³: neurocirurgia.

Plasma fresco congelado:

- Distúrbios de coagulação (INR > 1,5 + sangramento).

Crioprecipitado:

- Fibrinogênio < 100 mg/dL.

8. CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO

- Necessidade de monitorização contínua;
- Hemorragia moderada a grave;
- Instabilidade hemodinâmica;
- Reposição frequente de hemocomponentes;
- Exames com piora progressiva;
- Suspeita de sangramento interno.

9. CRITÉRIOS DE INDICAÇÃO E CONTRAINDICAÇÃO

9.1. Indicações para acionar o protocolo

- Presença de sangramento ativo de qualquer origem;
- Queda de hemoglobina sem causa definida;
- Plaquetopenia grave (< 20.000/mm³) com ou sem sangramento;
- Instabilidade hemodinâmica relacionado a perda sanguínea.;
- Hematêmese, melena, hematoquezia;
- Hemoptise;
- Hemorragia ginecológica intensa;
- Sangramento por feridas tumorais;
- Suspeita de sangramento interno.

9.2. Contraindicações (não acionamento)

- Sangramentos mínimos autolimitados sem repercussão clínica;
- Sangramento secundário a causas não relacionadas ao quadro oncológico e que não configuram urgência;
- Situações em cuidados exclusivamente paliativos onde a intervenção não trará benefício clínico, devendo ser ativado o plano de conforto.

10. RESPONSABILIDADES

10.1. Médicos

- Avaliar e estratificar gravidade;
- Definir condutas de estabilização e terapêuticas;
- Acionar especialistas;

- Prescrever hemoderivados e monitorar resposta;
- Determinar encaminhamento (UTI, internação, alta).

10.2. Enfermeiro da classificação de risco

- Avaliar sinais vitais e quadro inicial;
- Identificar sinais de alarme;
- Priorizar atendimento e direcionar fluxo.

10.3. Enfermeiro do pronto-socorro

- Monitorar paciente continuamente;
- Coletar exames e instalar acesso venoso;
- Administrar medicações e hemoderivados;
- Implementar medidas de controle hemorrágico;
- Coordenar equipe de técnicos.

10.4. Técnico de enfermagem

- Auxiliar na monitorização e cuidados diretos;
- Coletar exames conforme orientação;
- Administrar medicações conforme protocolos;
- Auxiliar no controle do sangramento e posicionamento do paciente.

11. INDICADORES DE MONITORAMENTO

- Tempo porta-atendimento para pacientes com sangramento;
- Tempo entre solicitação e administração de hemoderivados;
- Taxa de reabordagem por sangramento em até 72h;
- Eventos adversos relacionados a transfusões;
- Mortalidade associada a sangramentos;
- Percentual de adesão ao protocolo.

12. REFERÊNCIAS

ABHH – Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. **Guia de Transfusão**.

American College of Surgeons**. ATLS – 10th Edition**.

Franchini M, Lippi G. **Hemostatic abnormalities in malignancy**. *Clin Chem Lab Med.* 2014.

Kuter DJ. **Managing thrombocytopenia associated with cancer chemotherapy**. *Oncologist.* 2015.

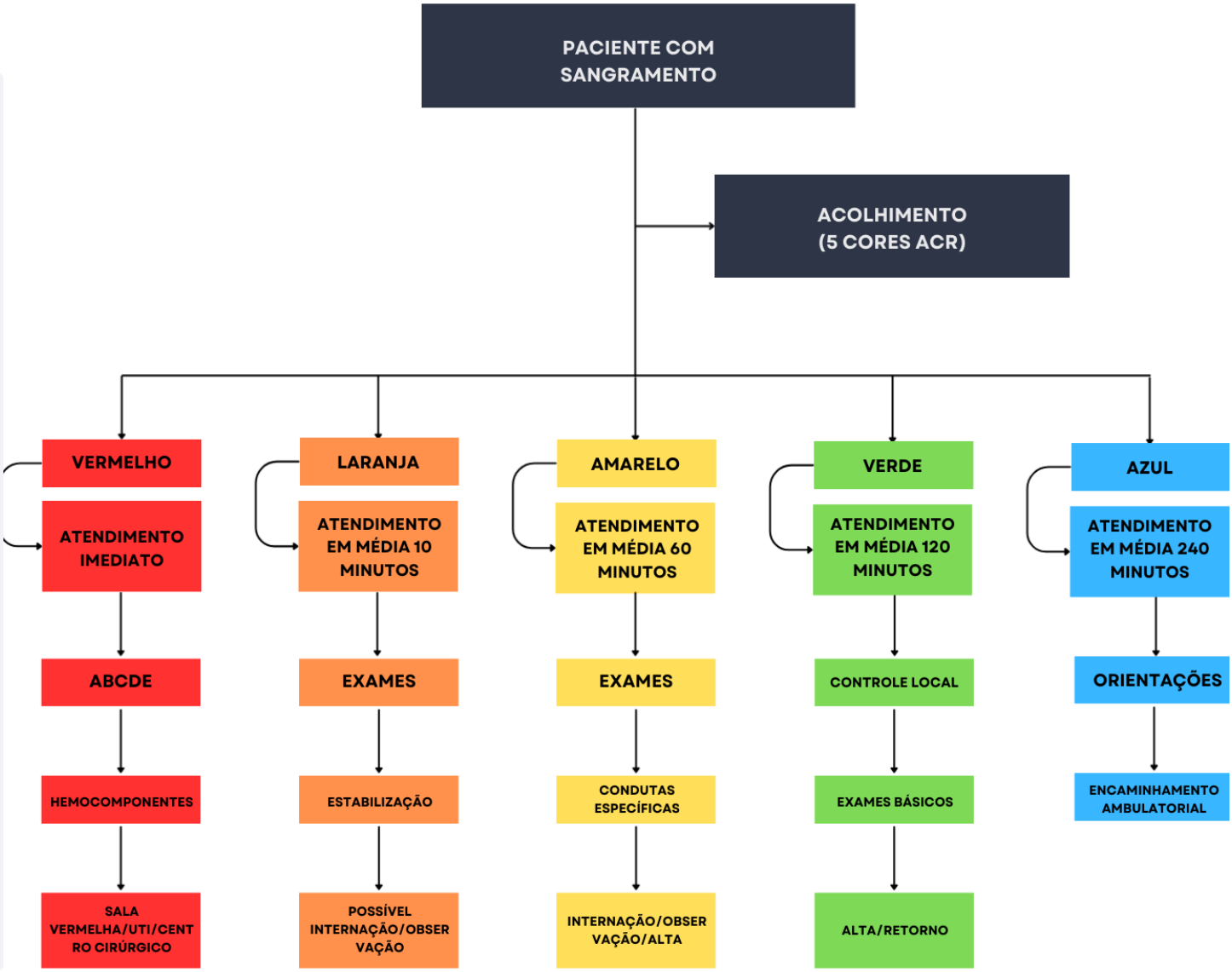
Ministério da Saúde. **Acolhimento com Classificação de Risco**. Brasília; 2014.

NCCN – National Comprehensive Cancer Network. **Cancer - and Treatment-Related Emergencies**.

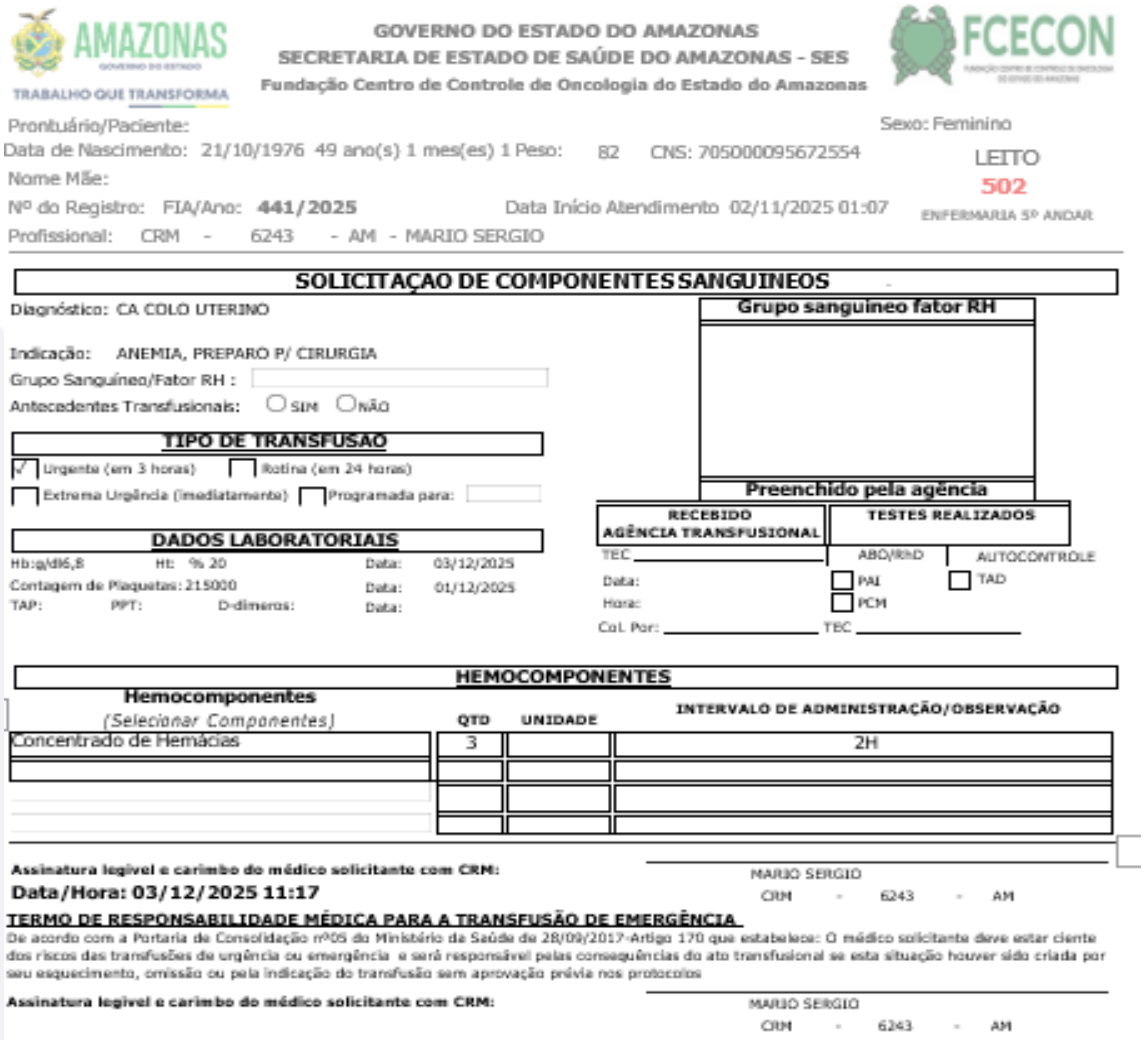
Stanworth SJ, et al. **Bleeding and coagulopathies in critical care**. *New England Journal of Medicine.* 2020.

13. ANEXOS

Anexo I – Fluxograma de Protocolo de Sangramento



Anexo II – Solicitação de componentes sanguíneos



AMAZONAS
TRABALHO QUE TRANSFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SES
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

FCECON

Prontuário/Paciente:
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 21/10/1976 49 ano(s) 1 mes(es) 1 Peso: 82 CNS: 705000095672554
LEITO
502
ENFERMARIA 5º ANDAR
Nome Mãe:
Nº do Registro: FIA/Ano: 441/2025 Data Início Atendimento 02/11/2025 01:07
Profissional: CRM - 6243 - AM - MARIO SERGIO

SOLICITAÇAO DE COMPONENTES SANGUINEOS

Diagnóstico: CA COLO UTERINO

Indicação: ANEMIA, PREPARO P/ CIRURGIA
Grupo Sanguíneo/Fator RH :
Antecedentes Transfusionais: ○ SIM ○ NÃO

Grupo sanguineo fator RH

TIPO DE TRANSFUSÃO

☑ Urgente (em 3 horas) ☐ Rotina (em 24 horas)
☐ Extrema Urgência (imediatamente) ☐ Programada para:

DADOS LABORATORIAIS

Hb:g/dl6,8 Ht: % 20 Data: 03/12/2025
Contagem de Plaquetas: 215000 Data: 01/12/2025
TAP: PPT: D-dimeros: Data:

Preenchido pela agência

RECEBIDO AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	TESTES REALIZADOS	
TEC	ABO/RhD	AUTOCONTROLE
Data:	☐ PAI	☐ TAD
Hora:	☐ PCM	
Col. Por:	TEC	

HEMOCOMPONENTES

Hemocomponentes (Selecionar Componentes)	QTD	UNIDADE	INTERVALO DE ADMINISTRAÇÃO/OBSERVAÇÃO
Concentrado de Hemácias	3		2H

Assinatura legível e carimbo do médico solicitante com CRM:
MARIO SERGIO
CRM - 6243 - AM
Data/Hora: 03/12/2025 11:17

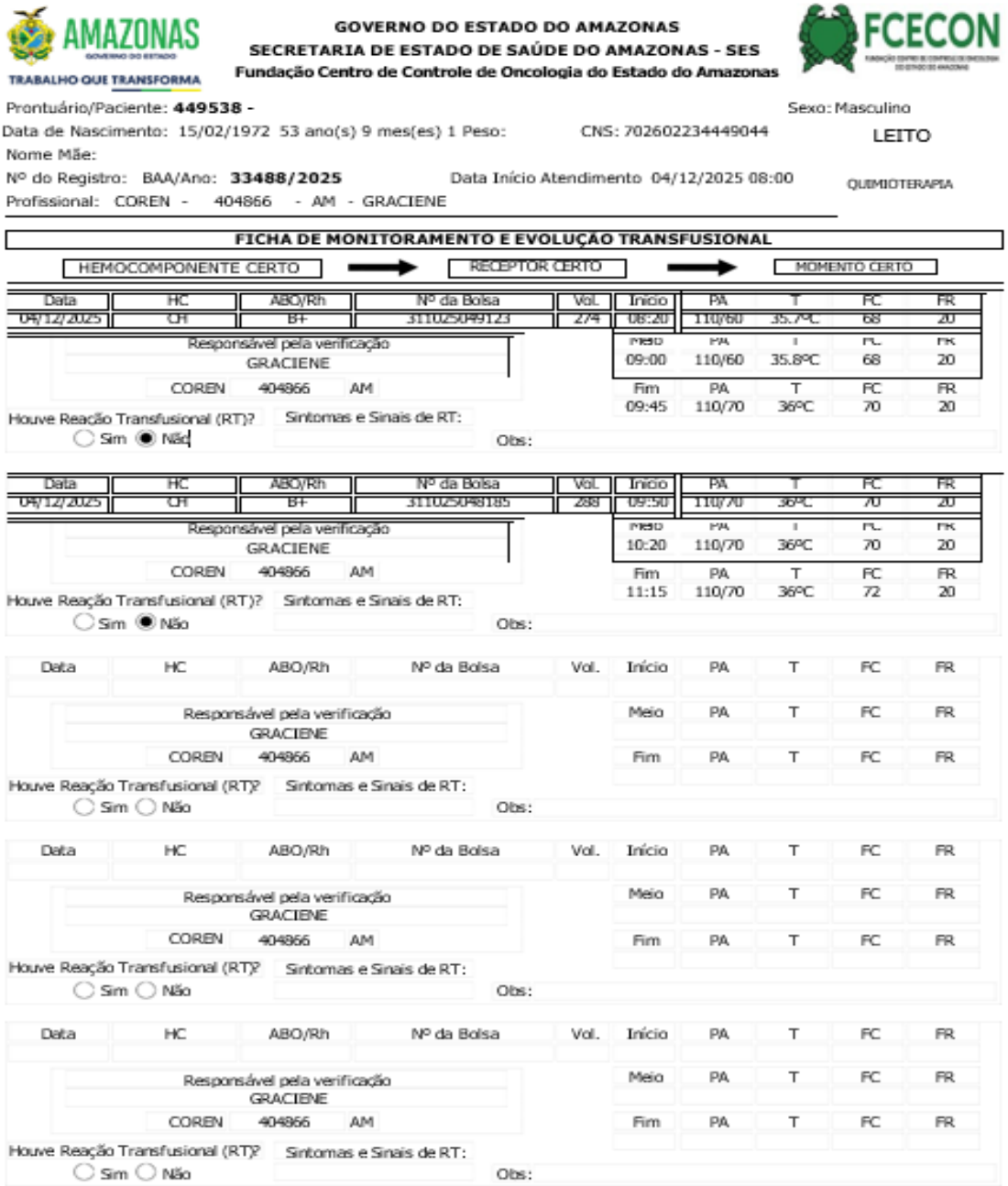
TERMO DE RESPONSABILIDADE MÉDICA PARA A TRANSFUSÃO DE EMERGÊNCIA

De acordo com a Portaria de Consolidação nº05 do Ministério da Saúde de 28/09/2017-Artigo 170 que estabelece: O médico solicitante deve estar ciente dos riscos das transfusões de urgência ou emergência e será responsável pelas consequências do ato transfusional se esta situação houver sido criada por seu esquecimento, omissão ou pela indicação do transfusão sem aprovação prévia nos protocolos

Assinatura legível e carimbo do médico solicitante com CRM:
MARIO SERGIO
CRM - 6243 - AM

Documento assinado digitalmente de acordo com a ICP-Brasil, MP 2.200-2/2001, por , registro - , endereço: RUA FRANCISCO ORELLANA, 215 - DOM PEDRO. CEP: 69040010 - MANAUS, AM, às de . <>

Anexo III – Ficha de monitoramento e evolução transfusional



AMAZONAS
TRABALHO QUE TRANSFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SES
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas

FCECON

Prontuário/Paciente: **449538** -
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 15/02/1972 53 ano(s) 9 mes(es) 1 Peso:
CNS: 702602234449044
LEITO
Nome Mãe:
Nº do Registro: BAA/Ano: **33488/2025**
Data Início Atendimento 04/12/2025 08:00
QUIMIOTERAPIA
Profissional: COREN - 404866 - AM - GRACIENE

FICHA DE MONITORAMENTO E EVOLUÇÃO TRANSFUSIONAL

HEMOCOMPONENTE CERTO → RECEPTOR CERTO → MOMENTO CERTO

Data	HC	ABO/Rh	Nº da Bolsa	Vol.	Início	PA	T	FC	FR
04/12/2025	CH	B+	31102504912J	274	08:20	110/60	35.7ºC	68	20

Responsável pela verificação
GRACIENE
COREN 404866 AM

Meio	PA	T	FC	FR
09:00	110/60	35.8ºC	68	20

Fim	PA	T	FC	FR
09:45	110/70	36ºC	70	20

Houve Reação Transfusional (RT)? ○ Sim ◉ Não
Sintomas e Sinais de RT:
Obs:

Data	HC	ABO/Rh	Nº da Bolsa	Vol.	Início	PA	T	FC	FR
04/12/2025	CH	B+	31102504818S	288	09:50	110/70	36ºC	70	20

Responsável pela verificação
GRACIENE
COREN 404866 AM

Meio	PA	T	FC	FR
10:20	110/70	36ºC	70	20

Fim	PA	T	FC	FR
11:15	110/70	36ºC	72	20

Houve Reação Transfusional (RT)? ○ Sim ◉ Não
Sintomas e Sinais de RT:
Obs:

Data	HC	ABO/Rh	Nº da Bolsa	Vol.	Início	PA	T	FC	FR

Responsável pela verificação
GRACIENE
COREN 404866 AM

Meio	PA	T	FC	FR

Fim	PA	T	FC	FR

Houve Reação Transfusional (RT)? ○ Sim ○ Não
Sintomas e Sinais de RT:
Obs:

Data	HC	ABO/Rh	Nº da Bolsa	Vol.	Início	PA	T	FC	FR

Responsável pela verificação
GRACIENE
COREN 404866 AM

Meio	PA	T	FC	FR

Fim	PA	T	FC	FR

Houve Reação Transfusional (RT)? ○ Sim ○ Não
Sintomas e Sinais de RT:
Obs:

Data	HC	ABO/Rh	Nº da Bolsa	Vol.	Início	PA	T	FC	FR

Responsável pela verificação
GRACIENE
COREN 404866 AM

Meio	PA	T	FC	FR

Fim	PA	T	FC	FR

Houve Reação Transfusional (RT)? ○ Sim ○ Não
Sintomas e Sinais de RT:
Obs:

14. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	05/12/2025	Elaboração do Protocolo

Elaboração: **Comissão de elaboração do Protocolo Institucional de Manejo do Sangramento em Pacientes Oncológicos na Unidade de Pronto Socorro – Serviço de Urgência e Emergência** • Rosangela das Neves Smith – Gerente do Serviço de Urgência e Emergência • Rayanne da Silva Souza – Gerente do Serviço de Hemoterapia • Emanuel Pires Corrêa – Médico assistencial do Serviço de Urgência e Emergência	**Data:** 05/12/2025 ROSANGELA DAS NEVES SMITH:42847877215 Assinado de forma digital por ROSANGELA DAS NEVES SMITH:42847877215 Dados: 2025.12.10 16:31:37 -04'00' gov.br Documento assinado digitalmente RAYANNE DA SILVA SOUZA Data: 12/12/2025 16:11:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br gov.br Documento assinado digitalmente EMANUEL PIRES CORREA Data: 16/12/2025 08:28:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Aprovação: Gerson Antônio dos Santos Mourão – Diretor Presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas	**Data:** 05/12/2025 GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURAO:05429005215 Assinado de forma digital por GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURAO:05429005215